

TEMA 2.15 • TRAUMATOLOGÍA

Lumbago, Cervicalgia, Hombro Doloroso, Codo Doloroso, Tendinitis, Bursitis, Fibromialgia

PERFIL EUNACOM 1.10.1.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Este artículo aborda el manejo clínico de las patologías musculoesqueléticas no articulares más frecuentes en la práctica del médico general y muy preguntadas en el examen EUNACOM. Se agrupan bajo el concepto de reumatismo de partes blandas.

Lumbago y Lumbociática

El **lumbago** se define como dolor en la zona lumbar. La causa más frecuente es el **lumbago mecánico**, secundario a debilidad de la musculatura axial (lumbar y abdominal), lo que genera posiciones viciosas e irritación de estructuras articulares, musculares o nerviosas.

Clasificación Clínica

TABLA 2.15.1: TIPO DE LUMBAGO VS CARACTERÍSTICAS

TIPO DE LUMBAGO	CARACTERÍSTICAS	MANEJO
Mecánico	Aumenta con movimiento, disminuye con reposo.	Médico (AINEs + Kine).
Inflamatorio	Aumenta con reposo, disminuye con ejercicio. Sugiere Espondilitis Anquilosante .	Estudio con imágenes y derivación.
Lumbociática	Dolor irradiado a extremidades inferiores.	Igual al lumbago (salvo compromiso neurológico).

Signos de Alarma (Red Flags)

La presencia de estos signos obliga a solicitar una **Resonancia Magnética (RM)** de columna de forma urgente o prioritaria.

- **Sospecha de Fractura:** Antecedente de trauma, uso crónico de corticoides, adultos mayores u osteoporosis conocida.
- **Sospecha de Cáncer:** Antecedente personal de neoplasia, baja de peso inexplicable, síntomas constitucionales.
- **Sospecha de Infección:** Fiebre asociada a dolor lumbar.
- **Compromiso Neurológico:** Paresia (baja de fuerza), hipoestesia (baja de sensibilidad) o hiporreflexia (caída de reflejos).
- **Evolución:** Dolor que dura más de 6 semanas o que empeora tras 2 semanas de tratamiento bien llevado.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Para el EUNACOM: La simple irradiación del dolor a la pierna (lumbociática) **no** es un signo de alarma por sí solo. El signo de alarma real es el déficit motor, sensitivo o de reflejos.

NOTA CLÍNICA

La **Espondilodiscitis** es una infección del disco intervertebral que clásicamente se presenta como una lumbociática asociada a fiebre.

Tratamiento

1. **Reposo relativo:** No se recomienda reposo en cama absoluto prolongado. 2. **AINEs:** Manejo sintomático del dolor. 3.

Kinesioterapia: No se inicia en la fase aguda de dolor intenso. Su objetivo es fortalecer la musculatura para prevenir recurrencias.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

La cirugía en la hernia del núcleo pulposo (HNP) solo se indica ante fracaso del tratamiento médico bien llevado o compromiso neurológico agudo.

Cervicalgia y Cervicobraquialgia

El manejo de la **cervicalgia** (dolor de cuello) y la **cervicobraquialgia** (dolor cervical irradiado al brazo) sigue exactamente la misma lógica que el lumbago: manejo médico inicial con AINEs/Kine y estudio con RM solo ante signos de alarma.

Hombro Doloroso

1. Síndrome de Manguito Rotador

Es la causa más común. Se produce por movimientos repetitivos que inflaman los tendones (especialmente el supraespinoso). - **Clínica:** Dolor nocturno que aumenta al acostarse sobre el hombro afectado. Dolor a la abducción y extensión contra resistencia. - **Diagnóstico:** Clínico. El examen de elección para objetivar la inflamación es la **Ecografía** (más costo-efectiva). - **Tratamiento:** Reposo, AINEs y kinesioterapia motora (pudiendo usar ultrasonido).

2. Capsulitis Adhesiva (Hombro Congelado)

- **Clínica:** Limitación de la movilidad **tanto activa como pasiva**. Pasa por una fase inicial muy dolorosa y luego una fase de anquilosis (rigidez) donde el dolor cede pero el hombro no se mueve. - **Tratamiento:** A diferencia del manguito rotador, aquí se utilizan **corticoides** y una kinesioterapia intensiva para recuperar rango articular.

Codo Doloroso

Se dividen principalmente según la zona de inserción tendinosa afectada (entesitis):

- **Epicondilitis Lateral (Codo de Tenista):** Dolor en la inserción de los músculos **extensores** del antebrazo (cara lateral del codo).
- **Epitrocleititis o Epicondilitis Medial (Codo de Golfista):** Dolor en la inserción de los músculos **flexores** (cara medial del codo).

Tratamiento: Reposo, AINEs, Kinesioterapia y el uso de una **epicondilara** (banda de descompresión) que libera tensión en la entesis.

Tendinitis y Bursitis

Tendinitis Frecuentes

Se caracterizan por dolor a la palpación y al estiramiento del tendón específico.

- **Pata de Ganso:** Dolor en la zona medial e inferior de la rodilla. Asociada a trekking o caminatas en pendiente.
- **Tendinitis Rotuliana:** Dolor en la tuberosidad tibial. Su variante en adolescentes es la enfermedad de **Osgood-Schlatter**.
- **Fascia Lata (Banda Iliotibial):** Dolor en la cara lateral de la rodilla. Típica de corredores ("**rodilla del maratonista**").
- **Tendinitis de De Quervain:** Dolor en la zona lateral de la muñeca (extensor corto y abductor largo del pulgar).

Bursitis

Inflamación de la bursa (saco sinovial peritendinoso). A diferencia de la tendinitis, suele presentar **eritema y aumento de volumen visible**.

- **Bursitis Olecraniana:** Aumento de volumen en la punta del codo.
- **Bursitis Pterocantérica:** Dolor sobre el trocánter mayor del fémur.
- **Bursitis Prepatelar:** Inflamación sobre la rótula.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Para diferenciar una Bursitis de una **Artritis Séptica**: En la bursitis la inflamación es superficial y extraarticular; en la artritis séptica hay derrame intraarticular y limitación dolorosa de todo el rango de movimiento de la articulación.

Fibromialgia

Es un trastorno de sensibilización central caracterizado por dolor musculoesquelético generalizado.

- **Diagnóstico:** Es **estrictamente clínico**. Se basa en la presencia de dolor a la compresión de "puntos gatillo" (cervical, trapecio, codos, rodillas, glúteos, etc.) por más de 3 meses.
- **Asociaciones:** Frecuente asociación con astenia (fatiga), trastornos del sueño y otros cuadros somatomorfos como el **Síndrome de Intestino Irritable**.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Si un paciente con clínica de fibromialgia presenta **VHS (velocidad de sedimentación) elevada** o **CK (creatina quinasa) alta**, se debe sospechar otros diagnósticos: - VHS alta: Pensar en **Polimialgia Reumática**. - CK alta: Pensar en **Polimiositis**.

Tratamiento de la Fibromialgia

El manejo debe ser multidisciplinario: 1. **Ejercicio aeróbico:** Fundamental (especialmente ejercicios de elongación). 2. **Moduladores del dolor:** - **Tricíclicos (Amitriptilina):** Primera línea por costo, aunque tienen más efectos adversos. - **Pregabalina o**

Gabapentina: Muy eficaces para el manejo del dolor crónico. 3. **Apoyo psicológico.**

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Hombre de cuarenta y dos años consulta por lumbago de tres semanas de evolución. Refiere que el dolor aumenta al moverse y mejora significativamente cuando está acostado en reposo. No tiene fiebre, ni baja de peso, ni irradiación a extremidades, ni debilidad muscular. ¿Cuál es el manejo inicial más adecuado?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Lumbago, Cervicalgia, Hombro Doloroso, Codo Doloroso, Tendinitis, Bursitis, Fibromialgia. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Las causas, la más frecuente es el lumbago mecánico, pero hay otras,
- Ahora, el diagnóstico de esos clínicos y el tratamiento son esas tres cosas,
- que está comprimiendo y no responde al tratamiento médico,
- sino que la falta de respuesta al tratamiento médico
- Y lo importante es que se manejan igual que el lumbago
- Ahora, el diagnóstico es clínico,
- pero la ecografía sería el examen para objetivar a ir la inflamación.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (LUMBAGO, CERVICALGIA, HOMBRO DOLOROSO, CODO DOLOROSO, TENDINITIS, BURSITIS, FIBROMIALGIA)**PREGUNTA 1**

Hombre de cuarenta y dos años consulta por lumbago de tres semanas de evolución. Refiere que el dolor aumenta al moverse y mejora significativamente cuando está acostado en reposo. No tiene fiebre, ni baja de peso, ni irradiación a extremidades, ni debilidad muscular. ¿Cuál es el manejo inicial más adecuado?

- A)** Solicitar resonancia magnética lumbar para estudio etiológico
- B)** Reposo absoluto en cama por dos semanas hasta la remisión del dolor
- C)** Reposo relativo, AINE y derivación a quinesioterapia una vez aliviado el dolor
- D)** Corticoides orales por el componente inflamatorio del cuadro
- E)** Derivación urgente a neurocirugía por riesgo de compresión medular

PREGUNTA 2

Mujer de treinta y cinco años deportista, tenista amateur, consulta por dolor en la cara lateral del codo derecho que lleva dos meses de evolución y que aumenta al extender la muñeca contra resistencia. No hay eritema ni aumento de volumen articular. ¿Cuál es el diagnóstico y el manejo inicial correcto?

- A)** Bursitis del olécranon: AINE más calor local
- B)** Epitrocleitis o codo del golfista: reposo, AINE y epicondilera
- C)** Artritis séptica de codo: punción articular urgente y antibióticos
- D)** Epicondilitis lateral o codo del tenista: reposo, AINE, epicondilera y quinesioterapia
- E)** Tendinitis del manguito rotador: ecografía de hombro y corticoides

PREGUNTA 3

Mujer de cuarenta y ocho años consulta por dolor generalizado en múltiples grupos musculares, fatiga crónica y trastornos del sueño de ocho meses de evolución. Al examen tiene dolor a la compresión en puntos cervicales, trapecios, epicóndilos y cara medial de las rodillas. La VHS y la PCR están dentro de rangos normales. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento de primera línea?

- A)** Polimialgia reumática: corticoides orales en dosis bajas
- B)** Fibromialgia: ejercicio físico más moduladores del dolor como pregabalina
- C)** Artritis reumatoide: metotrexato como fármaco modificador de la enfermedad
- D)** Polimiositis: biopsia muscular y corticoides sistémicos
- E)** Lumbago crónico con irradiación generalizada: resonancia magnética lumbar

RESUMEN: LUMBAGO, CERVICALGIA, HOMBRO DOLOROSO, CODO DOLOROSO, TENDINITIS, BURSITIS, FIBROMIALGIA

Varios temas que se preguntan habitualmente en su clínica, ya en reumatología, pero vamos a ver además con el manejo en el sentido que como médico general hay que saber manejarlo en detalles, aunque les adelanto, se manejan en general de manera bastante similar. Son lumbago, cervicalgia, hombro doloroso, codo doloroso, tendinitis, bursitis y fibromialgia, que es un tema aparte, pero lo vamos a ver ahora. Empecemos con lumbago, ¿qué es lumbago? Dolor lumbar, dolor de espalda. Las causas, la más frecuente es el lumbago mecánico, pero hay otras, y recuerden que el lumbago mecánico se debe a una debilidad de la musculatura lumbar habitualmente, lo cual hace que se adopte alguna posición viciosa, algún movimiento que no sea el más correcto y provoca irritación de alguna de las estructuras y esa articular, nerviosa, musculare, etc. Pero es debilidad de la musculatura axial. Ahora, ¿qué es lo característico del lumbago mecánico? Es que aumenta con los movimientos y disminuye con el reposo. Ahora, el diagnóstico de esos clínicos y el tratamiento son esas tres cosas, reposo relativo, AINEs y quinesioterapia. Ahora, la quinesioterapia no se hace de inmediato, se hace después de que el dolor ya haya mejorado y va dirigida justamente a fortalecer los músculos de la espalda y del abdomen en el sentido en que se van a prevenir la recurrencia. Recuerden, el lumbago no es una enfermedad solamente aguda, sino que además es residivante, y hay que enfocarlo de esa manera porque puede ser muy molesto